

Procedimento Operacional Padrão – POP					
Emissão 16/12/2025	Próxima Revisão 16/12/2027	POP.SES.DAP.DGE.064	Versão nº 01	Página 1/12	Anexos 0

Nome do Procedimento: Consulta de rotina do Adolescente na Atenção Primária à Saúde (10 a 19 anos)

Gerência(s) Responsável(eis) pelo(s) Serviço(s) Executante(s): Gerências distritais da Atenção Primária

Serviço(s) Responsável(eis) Pela Execução do POP: Atenção Primária à Saúde (APS)

Cargo(s) Responsável(eis) Pela Execução das Tarefas: Enfermeiro e Médico da Atenção Primária à Saúde

Objetivo(s): Orientar médicos e enfermeiros da Atenção Primária à Saúde sobre os tópicos a serem abordados na consulta programada do adolescente

Recursos necessários:

- Computador;
- Acesso à Internet;
- Acesso ao prontuário eletrônico;
- Estetoscópio;
- Esfigmomanômetro infantil e adulto;
- Otoscópio;
- Fita métrica;
- Balança digital antropométrica;
- Tabela de Percentil de Pressão Arterial Sistêmica;
- Caderneta de Saúde do Adolescente.

DEFINIÇÃO

A adolescência é uma fase do ciclo vital compreendida entre a infância e a vida adulta, caracterizada por intensas transformações físicas, psicológicas e sociais, que ocorrem de forma progressiva.

A consulta programada do adolescente deve ser incentivada pela equipe de saúde, pois esse período apresenta mudanças significativas, físicas, emocionais e sociais.

1. CONSULTA DO ADOLESCENTE

1.1. Âmbito de Atendimento

O atendimento abrange adolescentes entre 10 e 19 anos completos e a organização da agenda deve seguir a “Nota Orientativa nº 15/2025 - Calendário de Consultas de Puericultura e Odontologia de crianças de 0 a 9 anos completos e

Procedimento Operacional Padrão – POP					
Emissão 16/12/2025	Próxima Revisão 16/12/2027	POP.SES.DAP.DGE.064	Versão nº 01	Página 2/12	Anexos 0

adolescentes de 10 a 19 anos completos, na Atenção Primária à Saúde (APS)”, disponível no Processo SEI nº 25.0.088137-1.

Recomenda-se utilizar a Caderneta de Saúde do Adolescente para registro. No caso de falta da versão física, pode-se realizar a impressão da versão digital por meio dos links:

- Caderneta do Adolescente - Menina: [Caderneta adolescente menina](#)
- Caderneta do Adolescente - Menino: [Caderneta adolescente menino](#)

Importante: Os atendimentos aos adolescentes em conflito com a lei, que se encontram em medidas socioeducativas de privação ou liberdade provisória, deverão seguir as orientações descritas na *Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei* (SEI 20.0.016486-7):

- Os adolescentes em conflito com a lei que se encontram em internação provisória no Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) a referência em saúde será a Unidade Básica de Saúde da Família do Vila Nova Rural;
- Os adolescentes em conflito com a lei que encontram-se em cumprimento de medida sócio-educativa no Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório (CASEP), a referência em saúde será a Unidade Básica de Saúde da Família do Parque Guarani.

1.2. Privacidade e Confidencialidade

O adolescente têm direito à privacidade e à confidencialidade, devendo o sigilo profissional ser resguardado, salvo situações específicas:

- **Quebra de Sigilo:** A quebra do sigilo só é permitida em situações que envolvam risco à vida ou à integridade do adolescente ou de terceiros. O adolescente deve ser informado e orientado sobre os motivos da quebra. O Quadro 01 detalha algumas situações de manutenção e de quebra de sigilo.

- **Violência Sexual:** Toda relação sexual com pessoa com idade inferior a 14 anos é considerada estupro de vulnerável e, por isso, uma violência sexual, exigindo seguir *Protocolo Aconchegar* (Processo SEI nº 23.0.213387-5), além do preenchimento da Ficha de Notificação Compulsória no SIG Saudetech), mas a contracepção pode ser indicada, inclusive para menores de 14 anos.

Procedimento Operacional Padrão – POP					
Emissão 16/12/2025	Próxima Revisão 16/12/2027	POP.SES.DAP.DGE.064	Versão nº 01	Página 3/12	Anexos 0

Quadro 01. Quebra e Manutenção do Sigilo no Atendimento de Adolescentes (a partir de 14 anos)

MANUTENÇÃO DO SIGILO	QUEBRA DE SIGILO
• Relacionamentos afetivos e sexual (exceto por violência); • Relato de experimento de drogas sem sinais de dependência; • Conflitos sobre sexualidade; • Prescrição de contraceptivos; • Teste rápido de IST, em adolescente maior de 11 anos 11 meses e 29 dias, com maturidade para adesão ao tratamento.	• Violências; • Autoagressão; • Ideação suicida; • Fuga de casa; • Bullying; • Sinais de dependência química escalonada; • Gravidez e abortamento; • Transtornos mentais; • Bulimia, anorexia, vigorexia e ortorexia; • Não adesão ao tratamento, levando à risco o adolescente ou terceiros.

1.3. Atendimento Desacompanhado (12 a 18 anos)

Adolescentes de **12 a 18 anos completos** podem ser atendidos desacompanhados, com garantia de autonomia e sigilo. Na ocorrência de dúvida, consultar a Circular - *Orientação e esclarecimento sobre os Atendimentos de Saúde no Município de Joinville, incluindo Crianças e Adolescentes desacompanhados e Usuários sem documento de identificação oficial* (Processo SEI nº 22.0.334927-6).

Os passos sugeridos para atendimento são:

- Identificar e registrar no sistema SIG SaudeTech no campo “Evolução” o motivo da ausência do responsável;
- Avaliar a capacidade de compreensão do adolescente sobre a situação;
- Atender as demandas imediatas, respeitando o princípio da integralidade;
- Em caso de suspeita ou evidência de risco à integridade, buscar envolver adulto de confiança ou responsável legal;
- Para consultas de pré-natal ou outros procedimentos em menores de **12 anos**, o responsável legal deve acompanhar, exceto em urgência/emergência;

2. TÓPICOS ESSENCIAIS DA CONSULTA

Os tópicos a serem abordados incluem: Anamnese, Exame físico, Vacinas, Orientações de promoção/prevenção de agravos e Encaminhamentos (se necessários).

Procedimento Operacional Padrão – POP					
Emissão 16/12/2025	Próxima Revisão 16/12/2027	POP.SES.DAP.DGE.064	Versão nº 01	Página 4/12	Anexos 0

2.1. Anamnese

O profissional deve ter uma postura de compreensão e empatia. É indispensável reservar um momento individual com o adolescente, em ambiente que assegure acolhimento, privacidade e escuta qualificada.

Para uma anamnese bem estruturada, recomenda-se utilizar o **Protocolo HEEADSSS**, sendo uma ferramenta de avaliação psicossocial utilizada em consultas com **adolescentes**, com o objetivo de mapear áreas sensíveis da vida do jovem para identificar riscos e problemas de saúde mental ou social, de maneira confidencial.

Deve ser aplicado ao menos uma vez por ano ou sempre que houver indícios de fatores estressores. No Quadro 02 estão descritas as perguntas do Protocolo HEEADSSS.

Quadro 02. Perguntas sugeridas pelo Protocolo HEEADSSS para utilização em consultas com adolescentes

SIGLA E SIGNIFICADO	PERGUNTAS SUGERIDAS
H (Home) Casa	Onde você mora? Quem reside em casa com você? O ambiente é calmo ou “agitado”? Quem briga mais na tua casa?
E (Education/Employment) Educação / emprego	Sabe ler e escrever? Atualmente estuda? Em que ano/série escolar? Você trabalha? Em quê? horário – carteira assinada – interfere nos estudos?
E (Eating Disorders) Distúrbios alimentares	Já fez dieta? Gosta de seu corpo? Está contente com seu peso e altura?
A (Activities) Atividades	O que você faz além da escola? Pratica esporte? Qual? Quantas vezes por semana? Utiliza celular? Você joga videogame? Quanto tempo passa entre celular, games, TV, computador, telas em geral?
D (Drugs) Drogas lícitas / ilícitas	Você bebe? Com que frequência? Quando foi seu último porre? Onde costuma beber: em casa/bar/festas? Já experimentou kit (vodka + energético)? Já ficou de porre? Quando foi a última vez? Fuma tabaco? Início, quantidade de cigarros/maços fuma? Usou/usa outra droga? Qual, início, frequência, intoxicações / “overdose”?
S (Sexuality) Sexualidade	Já ficou? Está apaixonado/a? Divide sua intimidade corporal com alguém? Já teve relações sexuais? Com pessoas de sexo oposto, mesmo sexo, ou tanto faz?
S (Security) Segurança	Já sofreu algum tipo de violência? Onde? Por quem? Assalto? Bullying? Já causou violência em alguém? Consequências?
S (Suicide) Suicídio	O que você faz quando se sente triste: fica quieto? Chora? Já pensou em desaparecer / se machucar? Já tentou?

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2019.

Procedimento Operacional Padrão – POP

Emissão	Próxima Revisão	POP.SES.DAP.DGE.064	Versão	Página	Anexos
16/12/2025	16/12/2027		nº 01	5/12	0

Aspectos a abordar: Motivo da procura, histórico de saúde, situação vacinal, dinâmica familiar, hábitos de vida (alimentação, atividade física, sono, uso de telas), Saúde Bucal, Situações de risco (violências, uso de álcool/drogas) e Sexualidade e saúde mental.

2.2. Sexualidade e Planejamento Familiar

O início da vida sexual insere os adolescentes em contextos de vulnerabilidades às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e HIV/AIDS, gestação não planejada e aborto.

A orientação durante a consulta deve incluir informações claras, respeitando a autonomia do adolescente e os princípios da confidencialidade.

Orienta-se:

- Realizar educação em saúde, com enfoque na sexualidade responsável, corresponsabilidade masculina, autocuidado e no desenvolvimento de habilidades socioemocionais;
- Orientar e esclarecer sobre todos os métodos contraceptivos disponíveis, para que possam fazer escolhas livres e bem informadas, incluindo o respeito às suas concepções religiosas e culturais;
- Indicar os métodos contraceptivos de longa duração como opção mais eficaz, por não depender de esquecimentos na administração;
- Informar e orientar sobre a interação de alguns métodos contraceptivos com o uso de drogas lícitas e ilícitas;
- Esclarecer, orientar e apoiar adolescentes que são soropositivos, para o exercício da sexualidade responsável;
- Ofertar Testes Rápidos de IST para todo adolescente sexualmente ativo.
- Dupla Proteção: Incentivar o uso simultâneo do preservativo (masculino ou feminino) e de outro método contraceptivo.
- Orientar adolescentes de 10 a 13 anos completos (13 anos, 11 meses e 29 dias) à postergação da atividade sexual, (uma vez que a iniciação nessa faixa etária é considerada estupro de vulnerável e, portanto, violência sexual - Protocolo Aconchegar - SEI nº 23.0.213387-5) mas a contracepção pode ser indicada, inclusive para menores de 14 anos.
- Contracepção de Emergência (CE): Deve ser utilizada em até 72 horas após a relação sexual desprotegida. A dose ideal é de 1,5 mg de levonorgestrel.
 - *Instrução de Uso na Rede Municipal:* A paciente deve tomar **dois comprimidos** de 0,75 mg juntos para atingir a dose ideal.



Procedimento Operacional Padrão – POP

Emissão	Próxima Revisão	POP.SES.DAP.DGE.064	Versão	Página	Anexos
16/12/2025	16/12/2027		nº 01	6/12	0

2.3. Avaliação da Saúde Mental e Violência

Durante a consulta orienta-se:

- Ficar alerta para sinais como alterações de humor, queda no desempenho escolar, isolamento social, excesso de tempo em telas, exposição a fatores de risco, falas de desesperança, comunicação comprometida com a família, falta de apoio dos pais, violência na família, etc;
- Garantir escuta qualificada, confidencialidade e, se necessário, articular o cuidado com o psicólogo de referência;
- Notificar todas as formas de violências identificadas e encaminhar ao NPVA - Núcleo de Prevenção de Violência e Acidentes, na Vigilância Epidemiológica (VE) através do e-mail npva@joinville.sc.gov.br em até 24 horas após o acolhimento do usuário na unidade de saúde.

2.4. Alimentação e Nutrição

A adolescência é um período de intensas transformações, aliados a mudanças no comportamento alimentar, influenciam diretamente o estado nutricional e o crescimento.

Sugere-se:

- Realizar avaliação peso, estatura e IMC;
- Estimular o consumo de alimentos *in natura* e minimamente processados;
- Identificar sinais de transtornos alimentares e encaminhar, se necessário, para avaliação especializada;
- Realizar ações nas Unidades Escolares, conforme pactuação do Programa Saúde na Escola, conforme orientações disponíveis no Processo SEI nº 22.0.059839-9.

2.5. Vacinação

É importante que os profissionais realizem a conferência da caderneta vacinal em todas as consultas, em caso de atraso de alguma vacina, encaminhar a sala de vacina imediatamente após a consulta ou o mais breve possível.

Sugere-se:

- Conferir a caderneta vacinal em todas as consultas e encaminhar à sala de vacina em caso de atraso;

Procedimento Operacional Padrão – POP

Emissão	Próxima Revisão	POP.SES.DAP.DGE.064	Versão	Página	Anexos
16/12/2025	16/12/2027		nº 01	7/12	0

- Consultar o Calendário de Vacinação do Adolescente: [Vacinas do adolescente](#);
- A vacinação pode ser feita sem o responsável, desde que o adolescente apresente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) preenchido e assinado pelo responsável legal, disponível no Processo SEI nº 25.0.006611-2 ([Anexo SEI nº 27500773](#))

3. EXAME FÍSICO

O exame completo deve ser realizado em ambiente reservado preferencialmente, na presença de outro profissional de saúde ou de um familiar quando adolescente permitir, e em situações de suspeita de abuso sexual, essa presença torna-se obrigatória.

Para realização do exame físico, recomenda-se utilizar o *POP - Como Verificar os Sinais Vitais e Realizar Exame Físico em Criança e Adolescente* (SEI nº 25.0.088137-1).

3.1. Avaliações que devem ocorrer em toda consulta programada do adolescente

Algumas avaliações são de extrema importância e devem ocorrer em toda consulta programada do adolescente, principalmente no início da puberdade, sendo:

- **Crescimento e desenvolvimento:** Aferir peso, estatura e calcular o IMC.
- **Pressão Arterial:** Aferir conforme protocolos, utilizando valores de referência para idade, sexo e estatura.
- **Acuidade Visual:** Solicitar teste com a Escala de Snellen.
- **Maturação Sexual:** Classificar segundo a Escala de Tanner.
- **Mamas:** Inspeccionar e palpar, classificando o estágio puberal.
- **Genitália:** Avaliar ao final do exame.
 - **Meninas:** Realizar exame ginecológico apenas se sexualmente ativas ou com queixas específicas.
 - **Meninos:** Inspeccionar e palpar testículos, orientando sobre autoexame.

Quanto ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento puberal, sugere-se realizar consultas a intervalos conforme a fase em que se encontra o/a paciente, como descrito no [Quadro 03](#).



Procedimento Operacional Padrão – POP					
Emissão 16/12/2025	Próxima Revisão 16/12/2027	POP.SES.DAP.DGE.064	Versão nº 01	Página 8/12	Anexos 0

Quadro 03. Calendário de consultas do adolescente

CALENDÁRIO DE CONSULTAS DO ADOLESCENTE		
Fase de Crescimento	Consulta	
	Enfermagem/Médica*	Odontológica
No início da puberdade: meninas (entre 8 e 13 anos) e meninos (entre 9 e 14 anos)	De 3 em 3 meses	Anual
Aceleração	De 4 em 4 meses	
Desaceleração	Uma vez ao ano, próximo ao mês de aniversário	
Consulta de acompanhamento	Anual de 14 a 19 anos completos	

*Consultas intercaladas.

3.1.1. Avaliação da Velocidade de Crescimento

A velocidade máxima do **estirão puberal** também é variável de adolescente para adolescente:

- Estirão puberal em **meninas**: 8 a 10 cm/ano
- Estirão puberal em **meninos**: 10 a 12 cm/ano

A **velocidade de crescimento** (VC/ano) deve ser monitorada rotineiramente na adolescência, pois é um marcador sensível do estado nutricional e do desenvolvimento puberal. O cálculo pode ser feito por regra de três simples, considerando a variação da estatura em determinado período:

Exemplo: Adolescente (masculino) de 12 anos cresceu 4 cm em 4 meses.
Projeta-se:

4 cm → 4 meses

x cm → 12 meses

x = 12 cm/ano

Portanto, a velocidade está compatível com o estirão puberal normal do adolescente (masculino) que é entre 10 e 12cm/ano.

Procedimento Operacional Padrão – POP					
Emissão 16/12/2025	Próxima Revisão 16/12/2027	POP.SES.DAP.DGE.064	Versão nº 01	Página 9/12	Anexos 0

4. ENCAMINHAMENTOS

Caso seja identificada a necessidade de encaminhamento para outros pontos de atenção, seguir as orientações da Rede de Atenção ao Adolescente, conforme Quadro 04.

Quadro 04. Assistência na Atenção Integral à Saúde do Adolescente

Motivo do encaminhamento	Para onde encaminhar
Pediatra APS	Encaminhar conforme critérios que constam na Nota Técnica de Encaminhamento para Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria Na Atenção Primária , disponível no Processo SEI nº 23.0.145523-2.
Ginecologista APS	Encaminhar conforme critérios que constam na Nota Técnica de Encaminhamento para Ginecologia, Obstetrícia E Pediatria Na Atenção Primária , disponível no Processo SEI nº 23.0.145523-2.
Especialidades médicas	Encaminhamento via sistema SIG SaudeTech e protocolos vigentes da regulação.
Urgências e Emergências	Unidade de Pronto Atendimento (UPA) (UPA Leste, PA Norte; UPA Sul) Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria: Crianças e Adolescentes até 14 anos 11 meses e 29 dias; Hospital Municipal São José Adolescente acima de 14 anos 11 meses e 29 dias: Clínica Médica, Cuidados Paliativos, Acidente Vascular Cerebral (AVC), Queimaduras, Traumas, Ferimentos Graves. Hospital Regional Hans Dieter: Adolescente acima de 14 anos 11 meses e 29 dias: Clínica Médica, Cardiologia, Gastroenterologia, Infectologia, Nefrologia, Pneumologia, Ginecologia e Psiquiatria. Maternidade Darcy Vargas (MDV) Urgências obstétricas
Transtornos Mentais	CAPS IJ - até 17 anos 11 meses e 29 dias, atende usuários com transtornos mentais graves/persistentes e/ou do uso abusivo de substâncias psicoativas; CAPS Álcool e Drogas (AD) - Atende usuários a partir de 18 anos com sofrimento decorrente do uso/abuso de álcool e substâncias psicoativas (drogas). CAPS III Dê Lirios - Atende usuários a partir de 18 anos, com transtornos mentais agudos e/ou crônicos graves, que tenham necessidade de um cuidado intensivo. Seguir Linha de Cuidado em Saúde Mental (Processo SEI nº 20.0.176222-9)
Reabilitação / deficiência física	Serviço Especializado em Reabilitação (SER) encaminhar conforme Protocolo de Acesso ao Serviço Especializado em Reabilitação (SER) (Processo SEI nº 18.0.027664-5)
Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro do Autismo	Núcleo de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro do Autismo (NAIPE), encaminhar conforme Protocolo de Acesso aos Serviços Especializados em Atendimento à Pessoa com Deficiência Intelectual (DI) e Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) (Processo SEI nº 22.0.178204-5).

Fonte: Coordenação ESF, 2025



Procedimento Operacional Padrão – POP

Emissão	Próxima Revisão	POP.SES.DAP.DGE.064	Versão	Página	Anexos
16/12/2025	16/12/2027		nº 01	10/12	0

REFERÊNCIAS

BELO HORIZONTE. Secretaria Municipal de Saúde. **Protocolo de Atenção à Saúde do Adolescente**. Belo Horizonte: PBH, 2014. Disponível em:

[https://ftp.medicina.ufmg.br/ped/arquivos/2014/PBH%20protocolo saude adolescente 14 082014.pdf](https://ftp.medicina.ufmg.br/ped/arquivos/2014/PBH%20protocolo%20saude%20adolescente%2014082014.pdf)

BRASIL. Ministério da Saúde. **Orientações para o Atendimento ao Adolescente do Sexo Masculino na Atenção Básica**. Brasília: MS, 2010. Disponível em:

[https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/orientacoes_atendimento_adolescente_menino .pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/orientacoes_atendimento_adolescente_menino.pdf)

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de Enfermagem: Saúde da Criança e do Adolescente**. 2. ed. (Série Enfermagem Atenção Básica – SMS-SP). São Paulo: SMS/SP, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Saúde do Adolescente**. Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-do-adolescente>

BRASIL. Ministério da Saúde. **Adolescentes: Saúde Mental**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. (Cartilha). Disponível em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/cartilhas/2024/cartilha-adolescentes-saude-mental.pdf>

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-do-adolescente/diretrizes>

BRASIL. **Portaria Nº 2.561, de 23 De Setembro De 2020**. Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras providências. Brasília, 2020. Disponível no link

[/bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1271_06_06_2014.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1271_06_06_2014.html)

BRESCIANI, Helga Regina (org.). **Lei Do Exercício Profissional E Código De Ética Da Enfermagem: Legislação Comentada**. Florianópolis: Coren/SC, 2016. Disponível em:

[https://www.corensc.gov.br/wp-content/uploads/2016/11/Legisla%C3%A7%C3%A3o-Come ntada_site.pdf](https://www.corensc.gov.br/wp-content/uploads/2016/11/Legisla%C3%A7%C3%A3o-Comentada_site.pdf)



Procedimento Operacional Padrão – POP					
Emissão 16/12/2025	Próxima Revisão 16/12/2027	POP.SES.DAP.DGE.064	Versão nº 01	Página 11/12	Anexos 0

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Parecer técnico n. 04/2018**. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/parecer-no-04-2018-cofen-ctab/>

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA (COREN/SC). **Parecer técnico n. 008/CT/2018**. Disponível em: <https://www.corensc.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/PT-008-2018-Notifica%C3%A7%C3%A3o-aos-pais-ou-respons%C3%A1veis-legais-ou-Conselho-Tutelar-acerca-da-gesta%C3%A7%C3%A3o-na-adolesc%C3%Aancia.pdf>

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE PORTO ALEGRE - **Protocolo de Enfermagem Saúde da Criança e do Adolescente na Atenção Primária**. Porto Alegre, 2024. Acesso em 30/11/2025, disponível em: https://prefeitura.poa.br/sites/default/files/usu_doc/hotsites/sms/bvaps-biblioteca-virtual-de-atencao-primaria-saude/Protocolo%20-%20Sa%C3%BAde%20da%20Crian%C3%A7a%20e%20do%20Adolescente.pdf

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (FEBRASGO). **Manual de Orientação Sobre Saúde Reprodutiva**. 2022. Disponível em: <https://www.febRASGO.org.br/media/k2/attachments/FEMINAZ2.pdf>

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Diretrizes Sobre Intervenções de Promoção e Prevenção em Saúde Mental para Adolescentes: Ajudar Os Adolescentes a Prosperar**. Washington, D.C.: OPAS, 2023. Disponível em: <https://iris.paho.org/items/9b1deae6-0e54-4369-9222-7b50d1cb1b43>

SANTA CATARINA. **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei (2022 – 2025)**, Joinville, 2022. Disponível no SEI 20.0.016486-7.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Grupo de Trabalho Saúde na Era Digital. #Menos Telas #Mais Saúde – Atualização 2024**. Rio de Janeiro: SBP, 2024. (Manual de Orientação nº 163)

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Consulta do Adolescente: Abordagem Clínica e Orientações Éticas**. 2018. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/21512c-MO_-_ConsultaAdolescente_-_abordClinica_orientEticas.pdf

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Guia Prático De Atualização: Métodos Efetivos de Contracepção na Adolescência**. 2023. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/24200f-GPA_ISBN-_Atualiza_MetodosEfetivos_Contracepcao_Adl.pdf

Procedimento Operacional Padrão – POP

Emissão 16/12/2025	Próxima Revisão 16/12/2027	POP.SES.DAP.DGE.064	Versão nº 01	Página 12/12	Anexos 0
------------------------------	--------------------------------------	---------------------	------------------------	------------------------	--------------------

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
2025 Fernanda Cristina Spiller; Janaina Pravato Vicente Banin.	2025 Andressa Backes Emanuela Reiser; Valquiria Duarte; Vivianne Samara Conzatti; Sarah Spieker Jacinto; Willian Waldelino Custódio da Silva.	2025 Cibely Schipitoski; Juliana Antunes Safanelli; Luana Garcia Ferrabone; Vanessa Cardoso Pacheco.

Disponível em:

Sistema Eletrônico de Informação (SEI): Processo nº 25.0.088137-1

Protocolos, POPs e outros documentos da Saúde:

<https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/protocolos-pops-e-outros-documentos-da-sau-de/>

Alteração Após Revisão

Nº:	Data:	Responsável:
Alterações:		
Nº:	Data:	Responsável:
Alterações:		

